USTAWA

z 25.10.2026 r.

O NACZELNEJ KORONNEJ RADZIE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ORAZ O ZAWODZIE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. 1. Ustawa reguluje:

1) zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w Koronie Krulestwa Multikont;

2) ustrój, powoływanie i kompetencje Naczelnej Koronnej Rady Lekarzy i Lekarzy Dentystów, zwanej dalej „Radą”;

3) zasady wydawania przez Radę uchwał w sprawach zdrowia publicznego i zdrowia indywidualnego;

4) odpowiedzialność zawodową lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Ustawa wykonuje konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 57 Konstytucji Korony Krulestwa Multikont, oraz obowiązek władz publicznych zwalczania chorób epidemicznych.

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lekarzu — rozumie się przez to osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza;

2) lekarzu dentyście — osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;

3) pacjencie — osobę korzystającą ze świadczeń zdrowotnych;

4) prawie wykonywania zawodu (PWZ) — prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, stwierdzone decyzją Rady;

5) Radzie — Naczelną Koronną Radę Lekarzy i Lekarzy Dentystów;

6) stanie lekarskim — ogół lekarzy i lekarzy dentystów posiadających PWZ;

7) zdrowiu publicznym — stan zdrowia ludności Korony oraz zorganizowaną działalność organów władzy publicznej, Rady i podmiotów leczniczych na rzecz jego ochrony i poprawy;

8) zdrowiu indywidualnym — stan zdrowia konkretnej osoby oraz sferę relacji lekarza z pacjentem, objętą ochroną godności, prywatności, tajemnicy lekarskiej i zgody pacjenta;

9) chorobie publicznej — chorobę uznaną przez Radę za stanowiącą zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na zasięg, sposób szerzenia, ciężkość przebiegu lub skutki społeczne;

10) chorym — osobę, której stan zdrowia odbiega od stanu prawidłowego określonego przez wiedzę medyczną, rozpoznany przez lekarza na podstawie badania i kryteriów medycznych;

11) przyczynie choroby — przyczynę medyczną (etiologię) choroby, ustaloną na podstawie wiedzy medycznej; nie obejmuje ona ocen politycznych, moralnych, religijnych, rasowych ani społecznych;

12) uchwale w sprawie zdrowia indywidualnego — rozstrzygnięcie Rady w indywidualnej sprawie dotyczącej stanu zdrowia, choroby, jej przyczyny i leczenia; akt administracyjny;
13) uchwale — akt Rady w sprawach zdrowia publicznego, standardów, organizacji i etyki;
14) podmiocie leczniczym — publiczny lub prywatny podmiot wykonujący działalność leczniczą;
15) ministrze zdrowia — ministra koronnego właściwego do spraw zdrowia;
16) tajemnicy lekarskiej — obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia pacjenta i okolicznościach związanych z leczeniem.
2. Użyte w ustawie określenia „Korona", „Krul", „Senat Koronny", „Rząd Koronny" i „Skarbiec Koronny" mają znaczenie nadane im w Konstytucji Korony Krulestwa Multikont.

Art. 3. 1. Lekarz i lekarz dentysta wykonuje zawód w zgodzie z Konstytucją, prawem naturalnym, godnością istoty ludzkiej, wiedzą medyczną i sumieniem.
2. Ochrona życia i zdrowia jest najwyższym obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty.
3. W razie konfliktu dóbr lekarz kieruje się dobrem pacjenta, zasadą proporcjonalności i poszanowaniem godności istoty ludzkiej.
4. Zakazane jest dyskryminowanie pacjenta ze względu na pochodzenie, stan, majętność, wyznanie, przekonania, płeć, wiek, niepełnosprawność lub inne cechy.

Art. 4. 1. Lekarze i lekarze dentyści tworzą stan lekarski, którego naczelnym organem jest Rada.
2. Stan lekarski służy Koronie i pacjentom; wykonywanie zawodu jest służbą publiczną o szczególnym zaufaniu.

Art. 5. 1. Rada jest koronnym organem zawodowym posiadającym osobowość prawną.
2. Siedzibą Rady jest Tarkwinogród.
3. Rada jest niezależna w sprawach medycznych i etycznych; podlega Senatowi Koronnemu w zakresie określonym ustawą.

Art. 6. 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) strzeżenie godności i etyki stanu lekarskiego;
2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
3) ustalanie standardów postępowania medycznego i kryteriów orzeczniczych;
4) wydawanie uchwał w sprawach zdrowia publicznego i zdrowia indywidualnego;
5) prowadzenie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zdrowia;
7) współpraca z Senatem, Krulem, Rządem Koronnym, ministrem zdrowia, gminami, prowincjami i podmiotami leczniczymi;
8) edukacja i kształcenie ustawiczne;
9) współpraca międzynarodowa.

Art. 7. 1. Ustawa rozróżnia zdrowie publiczne i zdrowie indywidualne.

2. Uchwały w sprawach zdrowia publicznego służą stosowaniu ustawy, zawierają ustalenia medyczne, zalecenia i standardy zawodowe; nie stanowią aktów prawa powszechnie obowiązującego ani samodzielnej podstawy nakładania obowiązków na obywateli, podmioty lecznicze lub organy administracji.

3. Uchwały w sprawach zdrowia indywidualnego rozstrzygają indywidualne sprawy zdrowia i nie naruszają praw pacjenta, godności, prywatności i tajemnicy lekarskiej.

4. Uchwały w sprawach zdrowia indywidualnego są aktami administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 8. 1. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, przepisy o Senacie Koronnym, o działach administracji koronnej, o samorządzie gminnym i prowincji, o publikatorach koronnych, o Koronnej Izbie Kontroli oraz o Koronnym Trybunale Administracyjnym.

2. Ustawa nie narusza praw pacjenta, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności karnej i cywilnej.

ROZDZIAŁ 2
ZAWÓD LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Art. 9. 1. Tytuł „lekarz” i „lekarz dentysta” oraz tytuły specjalisty są chronione.

2. Tytułu „lekarz” może używać wyłącznie osoba posiadająca PWZ lekarza; tytułu „lekarz dentysta” — osoba posiadająca PWZ lekarza dentysty.

3. Zakazane jest używanie tytułu w sposób wprowadzający w błąd.

Art. 10. 1. PWZ lekarza albo lekarza dentysty może uzyskać osoba, która:

1) jest obywatelem Korony albo cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Korony;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) ukończyła studia na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym w koronnej uczelni medycznej albo posiada dyplom zagraniczny uznany zgodnie z art. 12 ust. 1;

4) odbyła staż podyplomowy;

5) zdała egzamin koronny;

6) złożyła ślubowanie, o którym mowa w art. 24;

7) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

8) posiada zdolność zdrowotną do wykonywania zawodu, stwierdzoną orzeczeniem lekarza wyznaczonego przez Radę;

9) złożyła wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 13.

2. Cudzoziemiec dodatkowo musi wykazać się znajomością języka koronnego w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Art. 11. 1. PWZ stwierdza w imieniu Rady jej trzyosobowy skład orzeczniczy w drodze decyzji administracyjnej. Do powoływania i działania składu stosuje się art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze, ust. 2 i 2a–2d.

2. Decyzja o odmowie stwierdzenia PWZ zawiera uzasadnienie i pouczenie o odwołaniu.

3. Od decyzji składu orzeczniczego przysługuje odwołanie do Rady w pełnym składzie na zasadach art. 45 ust. 9–12; od decyzji Rady — skarga do Koronnego Trybunału Administracyjnego.

4. Rada prowadzi postępowanie na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 12. 1. Akademickie uznanie dyplomu zagranicznego następuje na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce; w braku właściwej umowy nostryfikacji dokonuje minister koronny właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Rada ocenia kwalifikacje zawodowe posiadacza uznanego dyplomu na potrzeby przyznania PWZ. Może uzależnić przyznanie PWZ od zdania egzaminu wyrównawczego i odbycia stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem ratyfikowanych umów międzynarodowych.

3. Rada może odmówić przyznania PWZ, jeżeli kwalifikacje zawodowe nie odpowiadają wymaganiom wykonywania zawodu w Koronie; nie rozstrzyga ponownie o akademickim uznaniu dyplomu. Do decyzji stosuje się art. 11.

4. Cudzoziemiec może wykonywać zawód tymczasowo na podstawie zgody Rady, w zakresie i na czas określony. Do wydania zgody lub odmowy jej udzielenia stosuje się art. 11.

Art. 13. 1. Rada prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Rejestr obejmuje:

1) imię i nazwisko;

2) numer PWZ;

3) tytuł zawodowy i specjalizację;

4) datę wpisu i złożenia ślubowania;

5) informacje o zawieszeniu, ograniczeniu lub utracie PWZ;

6) inne dane określone w przepisach o ochronie danych osobowych.

3. Rejestr jest jawny w części dotyczącej imienia, nazwiska, tytułu, specjalizacji i numeru PWZ; pozostałe dane są chronione.

4. Minister zdrowia, Senat, organy ścigania i sądy mają dostęp do rejestru w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań.

Art. 14. 1. Lekarz i lekarz dentysta są obowiązani:

1) wykonywać zawód zgodnie z wiedzą medyczną, standardami Rady i sumieniem;

2) chronić życie i zdrowie pacjenta;

3) szanować godność, prywatność i przekonania pacjenta;

4) uzyskiwać zgodę pacjenta, o której mowa w art. 16;

5) zachować tajemnicę lekarską, o której mowa w art. 17;

6) prowadzić dokumentację medyczną, o której mowa w art. 18;

7) zgłaszać choroby publiczne w sposób określony w art. 42;

8) uczestniczyć w działaniach zdrowia publicznego w zakresie określonym ustawą;

9) podnosić kwalifikacje, o których mowa w art. 20;

10) unikać konfliktu interesów i nie przyjmować korzyści majątkowych za skierowanie, receptę lub badanie;

11) przestrzegać godności zawodu i zasad etyki Rady.

2. Lekarz i lekarz dentysta nie mogą wykonywać czynności zastrzeżonych dla innych zawodów medycznych.

Art. 15. 1. Pacjent ma prawo do:

1) informacji o stanie zdrowia, diagnozie, leczeniu i rokowaniu;

2) wyrażenia zgody na leczenie albo odmowy;

3) poszanowania godności, prywatności i intymności;

4) tajemnicy lekarskiej;

5) dostępu do dokumentacji medycznej;

6) drugiej opinii lekarskiej;

7) ulgi w cierpieniu i leczenia bólu;

8) zgłoszenia skargi do Rady, o której mowa w art. 62;

9) zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich;

10) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Pacjent ma prawo do informacji w języku dla niego zrozumiałym; w razie potrzeby zapewnia się tłumacza.

Art. 16. 1. Leczenie, badanie i eksperyment medyczny wymagają dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody pacjenta.

2. Zgoda może być pisemna, ustna albo wyrażona w sposób jednoznaczny; zgodę na zabieg operacyjny i eksperyment medyczny utrwala się na piśmie.

3. W razie braku zdolności do wyrażenia zgody zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy, a w razie jego braku — sąd powszechny.

4. W stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia lekarz może działać bez zgody, jeżeli zwłoka groziłaby śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu; fakt ten odnotowuje się w dokumentacji.

5. Eksperyment medyczny jest dopuszczalny wyłącznie za zgodą pacjenta, po zatwierdzeniu przez Radę i zgodnie z art. 42 Konstytucji.

Art. 17. 1. Lekarz i lekarz dentysta są obowiązani zachować w tajemnicy informacje o stanie zdrowia pacjenta, diagnozie, leczeniu, życiu rodzinnym i innych okolicznościach uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

2. Tajemnica lekarska nie ustaje po śmierci pacjenta; ujawnienie może nastąpić na jego wcześniejszą zgodę albo na zarządzenie sądu.

3. Ujawnienie jest dopuszczalne:

1) na wyraźną zgodę pacjenta;

2) w przypadkach przewidzianych ustawą, w szczególności w związku z chorobą publiczną, przestępstwem, ochroną życia lub zdrowia;

3) wobec organów uprawnionych na podstawie ustawy.

4. Ujawnienie musi być ograniczone do niezbędnego zakresu i odnotowane w dokumentacji.

Art. 18. 1. Lekarz i lekarz dentysta prowadzą dokumentację medyczną w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Dokumentacja obejmuje w szczególności: opis badania, diagnozę, przyczynę choroby, zastosowane leczenie, leki, zgodę pacjenta, informacje o powikłaniach i zalecenia.

3. Dokumentację przechowuje się przez 20 lat od ostatniego wpisu; dokumentację małoletniego — do ukończenia 25. roku życia.

4. Pacjent ma prawo do wglądu, kopii i sprostowania dokumentacji; po śmierci pacjenta — osoba bliska, chyba że pacjent sprzeciwił się za życia.

5. Dokumentacja jest chroniona przed dostępem osób nieuprawnionych; Rada może kontrolować jej prowadzenie.

Art. 19. 1. Lekarz i lekarz dentysta mogą udzielać świadczeń zdrowotnych na odległość (telemedycyna), jeżeli pozwala na to charakter świadczenia i stan pacjenta.

2. Przed udzieleniem świadczenia należy ustalić tożsamość pacjenta i uzyskać zgodę.

3. Telemedycyna nie może zastępować badania bezpośredniego, gdy jest ono niezbędne.

4. Dokumentacja telemedyczna jest prowadzona na zasadach art. 18; Rada określa standardy telemedycyny w drodze uchwały.

Art. 20. 1. Lekarz i lekarz dentysta są obowiązani do ciągłego podnoszenia kwalifikacji w cyklu pięcioletnim.

2. Rada określa programy i formy kształcenia ustawicznego oraz punktową ocenę.

3. Rada może zawiesić PWZ, jeżeli lekarz nie wypełnia obowiązku kształcenia przez dwa kolejne cykle.

Art. 21. 1. Lekarz i lekarz dentysta mogą wykonywać zawód w podmiocie publicznym lub prywatnym.

2. Do praktyki prywatnej stosuje się standardy Rady, z zachowaniem ochrony danych osobowych i praw pacjenta.

3. Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna są czynnościami zastrzeżonymi dla lekarzy; Rada określa standardy ich wykonywania.

4. Reklama usług medycznych nie może naruszać godności zawodu, wprowadzać w błąd ani obiecywać wyleczenia.

Art. 22. 1. Lekarz i lekarz dentysta są obowiązani udzielić pomocy w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, w zakresie swoich kwalifikacji.

2. Pomoc może być udzielona poza miejscem pracy; lekarz korzysta z ochrony prawnej, chyba że działa z rażącym niedbalstwem.

3. Odmowa pomocy w stanie nagłego zagrożenia stanowi przewinienie zawodowe.

Art. 23. 1. PWZ wygasa w razie:

1) zrzeczenia się;

2) utraty obywatelstwa albo prawa do legalnego pobytu, jeżeli ustawa tak stanowi;

3) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

4) trwałej niezdolności do wykonywania zawodu;

5) prawomocnego orzeczenia o pozbawieniu PWZ.

2. Trzyosobowy skład orzeczniczy Rady zawiesza PWZ w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem uznaniowego charakteru zawieszenia na podstawie art. 20 ust. 3, w razie:

1) tymczasowego aresztowania;

2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego o poważne przewinienie, jeżeli dalsze wykonywanie zawodu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów;

3) choroby zakaźnej zagrażającej pacjentom;

4) niewypełnienia obowiązku kształcenia przez dwa kolejne cykle, o których mowa w art. 20.

3. Zawieszenie trwa do ustania przyczyny, nie dłużej niż 5 lat, z zastrzeżeniem szczególnego limitu zabezpieczenia dyscyplinarnego określonego w art. 56 ust. 2.

4. Do składu orzeczniczego stosuje się art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze, ust. 2 i 2a–2d. Od decyzji przysługuje odwołanie do Rady w pełnym składzie na zasadach art. 45 ust. 9–12, a następnie skarga do Koronnego Trybunału Administracyjnego.

Art. 24. 1. Lekarz i lekarz dentysta składają ślubowanie wobec Przewodniczącego Rady w obecności dwóch członków Rady.

2. Rota ślubowania stanowi Załącznik nr 1 do ustawy.

3. Złożenie ślubowania odnotowuje się w rejestrze.

ROZDZIAŁ 3
NACZELNA KORONNA RADA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Art. 25. 1. Rada składa się z 10 członków: 5 lekarzy i 5 lekarzy dentystów.

2. W skład Rady wchodzą Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i 7 członków.

3. Wszystkich członków Rady powołuje Senat Koronny spośród lekarzy i lekarzy dentystów. Senat wskazuje spośród powołanych członków Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, w trybie określonym w art. 26 ust. 1; w tym samym trybie obsadza opróżnione funkcje na pozostałą część kadencji.

4. Rada jest organem kolegialnym.

Art. 26. 1. Senat Koronny powołuje członków Rady większością 3/5 ustawowej liczby senatorów.

2. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać:

1) Pierwszy Senator;

2) Marszałek Izby Multikont i Marszałek Izby Arystokratów;

3) Komisja Senatu Koronnego właściwa do spraw zdrowia;
4) minister zdrowia;
5) koronne uczelnie medyczne;
6) stowarzyszenia lekarzy i lekarzy dentystów;
7) grupa co najmniej 50 lekarzy lub lekarzy dentystów.

3. Senat może powołać na członka Rady każdą osobę spełniającą wymagania ustawowe, także niezgłoszoną jako kandydat.

4. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada PWZ i co najmniej 10 lat praktyki;
2) jest obywatelem Korony i korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
4) nie pełni funkcji w partii politycznej;
5) nie pozostaje w konflikcie interesów z zadaniami Rady;
6) wyróżnia się wiedzą medyczną i autorytetem etycznym.

5. Tryb zgłaszania kandydatur i powoływania określa Regulamin Senatu.

Art. 27. 1. Kadencja Rady trwa 6 lat i rozpoczyna się z dniem powołania wszystkich członków.

2. Członek Rady może być powołany ponownie tylko raz.

3. W razie wygaśnięcia mandatu Senat powołuje nowego członka na okres do końca kadencji.

4. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie śmierci, zrzeczenia się, odwołania lub utraty wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 4.

Art. 28. 1. Członek Rady składa wobec Senatu ślubowanie następującej treści: „Uroczyście ślubuję służyć wiernie Koronie Krulestwa Multikont, strzec godności stanu lekarskiego, działać zgodnie z wiedzą medyczną i sumieniem, nie ulegać wpływom politycznym ani interesom prywatnym, a dobro pacjenta i zdrowie publiczne stawiać ponad wszystko. Tak mi dopomóż honor i sumienie.”

2. Członek Rady jest niezależny; nie może przyjmować instrukcji od organów państwa, partii politycznych ani podmiotów gospodarczych.

3. Członek Rady nie może brać udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której zachodzi konflikt interesów; fakt wyłączenia odnotowuje się w protokole.

4. Członek Rady nie ponosi odpowiedzialności za głosowanie lub opinię wyrażoną w ramach Rady, chyba że naruszy prawo.

Art. 29. 1. Senat Koronny może odwołać członka Rady przed upływem kadencji wyłącznie w razie:
1) zrzeczenia się;
2) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji, stwierdzonej uchwałą Senatu;
3) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
4) rażącego naruszenia Konstytucji, ustawy lub etyki lekarskiej;
5) utraty obywatelstwa Korony lub PWZ;
6) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech kolejnych posiedzeniach;

7) ujawnienia konfliktu interesów, którego członek nie usunął.

2. Odwołanie następuje większością 2/3 ustawowej liczby senatorów.

3. Odwołanie wymaga uprzedniego wysłuchania członka Rady, chyba że jest to niemożliwe.

4. Członek Rady nie może być odwołany z powodów politycznych.

Art. 30. 1. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę, zwołuje posiedzenia, prowadzi obrady, podpisuje uchwały oraz wykonuje inne zadania określone ustawą.

2. Wiceprzewodniczący zastępują Przewodniczącego w razie nieobecności, w kolejności wskazanej przez Radę.

3. Prezydium Rady tworzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz dwóch członków wybranych przez Radę.

4. Prezydium przygotowuje porządek obrad, koordynuje prace Rady i wykonuje uchwały Rady.

Art. 31. 1. Sekretarza Rady powołuje Przewodniczący; Sekretarz kieruje Biurem Rady.

2. Rada uchwala Regulamin Rady większością 2/3 głosów; Regulamin ogłasza się w Monitorze Krulewskim.

Art. 32. 1. Rada obraduje co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący; zwołuje je także na wniosek 5 członków, Senatu, ministra zdrowia lub Krula.

3. Posiedzenia są jawne, z wyjątkiem spraw dotyczących danych pacjentów, tajemnicy lekarskiej i bezpieczeństwa Korony; w tych sprawach Rada obraduje na posiedzeniu niejawnym.

4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 6 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem szczególnych zasad orzekania w sprawach indywidualnych określonych w art. 45.

5. Uchwały w sprawach chorób publicznych, etyki i godności honorowych wymagają większości 2/3 głosów.

6. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Art. 33. 1. Rada wydaje:

1) uchwały w sprawach zdrowia publicznego;

2) uchwały w sprawach zdrowia indywidualnego;

3) uchwały w sprawach standardów i etyki;

4) uchwały organizacyjne.

2. Uchwały w sprawach zdrowia publicznego, uchwały w sprawach zdrowia indywidualnego, uchwały w sprawach standardów i etyki oraz Regulamin Rady ogłasza się w Monitorze Krulewskim; pozostałe uchwały organizacyjne podaje się do wiadomości członkom Rady.

3. Uchwała zawiera podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie i datę wejścia w życie.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, chyba że sama stanowi inaczej; uchwała w sprawie choroby publicznej może wejść w życie natychmiast, jeżeli Rada wskaże pilny interes zdrowia publicznego. Skuteczność i wykonalność uchwał w sprawach zdrowia indywidualnego określa Koronny

Kodeks Postępowania Administracyjnego; ogłoszenie wersji zanonimizowanej w Monitorze Krulewskim nie zastępuje doręczenia stronie i nie rozpoczyna biegu terminów zaskarżenia.

5. Uchwały są przekazywane Szefowi Pałacu Krula do ogłoszenia w Monitorze Krulewskim.

Art. 34. 1. Rada przedstawia Senatowi Koronnemu i Krulowi corocznie, do 31 marca, „Raport o stanie zdrowia Korony”.

2. Raport obejmuje stan zdrowia ludności, choroby publiczne, dostęp do świadczeń, kształcenie kadr i wnioski na przyszłość.

3. Raport jest jawny; Rada przedstawia go na uroczystym posiedzeniu w gmachu Senatu w obecności Pierwszego Senatora.

4. Senat i Krul mogą zażądać dodatkowych informacji i opinii.

Art. 35. 1. Rada prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzanego przez Senat.

2. Źródła dochodów Rady stanowią: dotacja ze Skarbca Koronnego, opłaty za wpis i egzaminy, składki, darowizny i inne dochody.

3. Rada prowadzi rachunek bankowy w Koronnym Banku Centralnym.

4. Rada podlega kontroli Koronnej Izby Kontroli w zakresie legalności, gospodarności i celowości.

Art. 36. 1. Rada ma pieczęć okrągłą z godłem Korony, napisem „NACZELNA KORONNA RADA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW” i rokiem rozpoczęcia kadencji.

2. Krul, na wniosek Rady, nadaje tytuł „Lekarza Koronnego” albo „Dentysty Koronnego” lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który przez co najmniej 25 lat wykonywał zawód i odznaczył się wybitnymi zasługami dla zdrowia i Korony.

3. Tytuł jest dożywotni i honorowy; nie zwalnia z obowiązków ustawowych.

4. Rada może nadać godność „Członka Honorowego Rady” osobie szczególnie zasłużonej dla zdrowia publicznego; uchwała wymaga 2/3 głosów.

5. Krul może nadać medal „Zasłużony dla Zdrowia Korony” na wniosek Rady.

ROZDZIAŁ 4
KOMPETENCJE RADY

Art. 37. 1. Rada jest najwyższym organem opiniodawczym, standaryzacyjnym i orzekającym stanu lekarskiego w sprawach zdrowia.

2. Rada wykonuje swoje kompetencje w granicach ustawy, Konstytucji i prawa naturalnego.

3. Uchwały Rady nie mogą naruszać praw pacjenta, godności, prywatności, tajemnicy lekarskiej i zasady proporcjonalności.

Art. 38. 1. Rada opiniuje projekty ustaw, dekretów i rozporządzeń dotyczących zdrowia, kształcenia medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych, leków, wyrobów medycznych, organizacji podmiotów leczniczych i zdrowia publicznego.

2. Organ przygotowujący projekt aktu przesyła go Radzie do opinii; Rada przedstawia opinię w terminie 30 dni.

3. Opinia Rady jest jawna; organ przygotowujący projekt ustosunkowuje się do niej na piśmie.

4. Rada może z własnej inicjatywy wydawać opinie i apele w sprawach zdrowia publicznego.

Art. 39. 1. Rada uchwala standardy postępowania diagnostycznego, leczniczego i profilaktycznego oraz Kodeks Etyki Lekarskiej.

2. Standardy określają zawodowe kryteria należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków ustanowionych ustawą, a Kodeks Etyki Lekarskiej — zawodowe zasady postępowania. Nie ustanawiają samodzielnie obowiązków obywateli lub podmiotów leczniczych ani ograniczeń praw pacjenta. Lekarz może odstąpić od standardu, jeżeli wymaga tego dobro pacjenta, a odstępstwo uzasadni w dokumentacji.

3. Rada monitoruje przestrzeganie standardów i może wydawać zalecenia.

4. Standardy i Kodeks Etyki ogłasza się w Monitorze Krulewskim.

Art. 40. 1. Rada określa programy specjalizacji, kryteria egzaminów specjalizacyjnych i warunki certyfikacji umiejętności.

2. Rada współpracuje z koronnymi uczelniami medycznymi i ministrem zdrowia w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego.

3. Rada uznaje kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą na zasadach art. 12.

4. Rada prowadzi rejestr specjalistów.

Art. 41. 1. Rada wydaje uchwały w sprawach zdrowia publicznego, w szczególności:

1) ustala wykaz chorób publicznych;

2) określa kryteria rozpoznawania, zgłaszania i klasyfikacji chorób publicznych;

3) określa środki zapobiegania i zwalczania chorób publicznych;

4) wskazuje prawa i obowiązki chorych, osób z kontaktu i podmiotów leczniczych wynikające z ustaw oraz ich zastosowanie w danej sytuacji;

5) określa organizację opieki w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego;

6) wydaje zalecenia i apele.

2. Uchwała w sprawie zdrowia publicznego wymaga uzasadnienia medycznego i etycznego.

3. Uchwała nie może nakładać obowiązków nieprzewidzianych ustawą ani naruszać godności, wolności i praw pacjenta. Ustalenia medyczne i zalecenia Rady nie zastępują ustawowej podstawy prawnej ani decyzji właściwego organu wymaganej do zastosowania środków ingerujących w prawa jednostki.

Art. 42. 1. Rada może uznać chorobę za publiczną, jeżeli stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na zasięg, sposób szerzenia, ciężkość przebiegu lub skutki społeczne.

2. Uchwała w sprawie choroby publicznej określa:

1) nazwę i definicję choroby;

2) kryteria rozpoznania i przyczynę medyczną;

3) sposób szerzenia i grupy ryzyka;

4) środki zapobiegania i zwalczania;

5) sposób wykonywania ustawowych obowiązków zgłaszania i nadzoru, bez rozszerzania ich zakresu podmiotowego lub przedmiotowego;

6) prawa chorych i osób z kontaktu wynikające z ustaw;

7) czas obowiązywania uchwały.

3. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów, uzasadnienia medycznego i etycznego oraz zasięgnięcia opinii ministra zdrowia.

4. Uchwałę ogłasza się w Monitorze Krulewskim; podlega ona nadzorowi Senatu, o którym mowa w art. 58.

5. Krul może, na wniosek Rady, ogłosić stan epidemii na czas określony; przedłużenie wymaga zgody Senatu.

Art. 43. 1. Rada może ogłosić stan zagrożenia zdrowia publicznego na okres do 90 dni, jeżeli istnieje bezpośrednie i poważne zagrożenie dla zdrowia ludności.

2. W stanie zagrożenia Rada może zalecić ministrowi zdrowia, gminom i prowincjom:

1) wzmocnienie nadzoru sanitarnego;

2) ograniczenie zgromadzeń;

3) czasowe zamknięcie podmiotów leczniczych lub szkół;

4) obowiązkowe szczepienia i badania, jeżeli ustawa tak stanowi;

5) inne środki proporcjonalne do zagrożenia.

3. Środki nie mogą naruszać godności, prywatności i praw pacjenta; ograniczenia wolności wymagają podstawy ustawowej i sądowej kontroli.

4. Senat może przedłużyć stan zagrożenia na wniosek Rady; Rada przedstawia Senatowi raport co 30 dni.

5. Stan zagrożenia nie zastępuje stanu epidemii ogłaszanego przez Krula.

Art. 44. 1. Rada wydaje uchwały w sprawach zdrowia indywidualnego, w szczególności:

1) badanie, diagnozę i leczenie;

2) rozpoznanie choroby i ustalenie przyczyny medycznej;

3) tajemnicę lekarską, zgodę i dokumentację;

4) telemedycynę;

5) medycynę estetyczną i chirurgię plastyczną;

6) eksperymenty medyczne;

7) prawa pacjenta i tryb rozpatrywania skarg.

2. Uchwały w sprawach zdrowia indywidualnego nie mogą naruszać praw pacjenta, godności, prywatności i tajemnicy lekarskiej.

3. Uchwały w sprawach zdrowia indywidualnego ogłasza się w Monitorze Krulewskim.

Art. 45. 1. Uchwałę w sprawie zdrowia indywidualnego wydaje w imieniu Rady trzyosobowy skład orzeczniczy, obejmujący co najmniej jednego lekarza i jednego lekarza dentystę, wyznaczony spośród członków Rady przez jej Przewodniczącego do konkretnej sprawy. Postępowanie wszczyna się na wniosek:

1) pacjenta;

2) lekarza lub lekarza dentysty;

3) Senatu, Krula, ministra zdrowia;

4) Rzecznika Praw Obywatelskich;

5) Koronnej Izby Kontroli.

2. Wyznaczając skład orzeczniczy, Przewodniczący Rady wskazuje przewodniczącego tego składu. Rozstrzygnięcie wymaga udziału wszystkich trzech członków i zapada zwykłą większością głosów; podpisują je wszyscy członkowie składu. Nie stosuje się art. 30 ust. 1 w zakresie podpisywania rozstrzygnięcia ani art. 32 ust. 4–6.

2a. Członek Rady podlega wyłączeniu od rozpoznania sprawy, jeżeli zachodzą okoliczności wywołujące uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności konflikt interesów określony w art. 28 ust. 3. Wyłączenie obejmuje także członków składu, który wydał rozstrzygnięcie zaskarżone odwołaniem.

2b. O wyłączeniu członka składu i wyznaczeniu w jego miejsce innego uprawnionego członka Rady rozstrzyga Przewodniczący Rady; o wyłączeniu Przewodniczącego Rady rozstrzyga niewyłączony Wiceprzewodniczący, a w braku takiej osoby — Rada bez udziału osoby, której wyłączenie dotyczy.

2c. W razie wyłączenia albo nieobecności Przewodniczącego Rady zadania związane z wyznaczeniem składu wykonuje niewyłączony Wiceprzewodniczący; jeżeli obaj Wiceprzewodniczący również nie mogą działać, zadania te wykonuje najstarszy wiekiem uprawniony członek Rady. Osoba ta nie rozstrzyga o własnym wyłączeniu.

2d. Wakat lub wyłączenie nie uprawnia do orzekania w składzie mniejszym niż trzy osoby. Jeżeli nie można wyznaczyć składu spełniającego wymagania ust. 1, zawiadamia się stronę o przyczynie zwłoki i podejmuje czynności niezbędne do usunięcia przeszkody, a w razie wakatu — zawiadamia Senat o konieczności uzupełnienia składu Rady. Zachowuje się prawo strony do zaskarżenia bezczynności lub przewlekłości na zasadach ogólnych.

3. Uchwała wymaga zgody osoby, której dotyczy, chyba że ustawa stanowi inaczej; w sprawie choroby publicznej badanie może być zarządzone na podstawie ustawy.

4. Uchwała stwierdza, czy osoba jest chora, wskazuje chorobę, jej przyczynę medyczną, zalecane postępowanie i rokowanie.

5. Uchwała opiera się wyłącznie na kryteriach medycznych, dowodach i opiniach biegłych; nie może być oparta na przesłankach politycznych, moralnych, religijnych, rasowych lub społecznych.

6. Przed wydaniem uchwały osoba ma prawo do wysłuchania, przedstawienia dowodów i ustanowienia pełnomocnika.

7. Uchwała jest wiążąca dla organów publicznych, jeżeli ustawa uzależnia skutek prawny od stanu zdrowia.

8. Uchwała jest poufna; pełny tekst otrzymuje osoba, której dotyczy; w Monitorze Krulewskim ogłasza się wersję zanonimizowaną.

9. Od rozstrzygnięcia składu orzeczniczego przysługuje odwołanie do Rady w pełnym składzie w terminie 14 dni od doręczenia rozstrzygnięcia stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem składu, który wydał

rozstrzygnięcie; stosuje się odpowiednio przepisy Koronnego Kodeksu Postępowania Administracyjnego o odwołaniach, w tym o wstrzymaniu wykonania rozstrzygnięcia.

10. Pełny skład oznacza posiedzenie plenarne Rady, na które wzywa się wszystkich jej członków uprawnionych do rozpoznania odwołania, a nie wyodrębniony zespół odwoławczy. W orzekaniu nie uczestniczą członkowie wyłączeni na podstawie ust. 2a, w tym osoby, które wydały zaskarżone rozstrzygnięcie.

11. Rada rozpoznaje odwołanie przy udziale co najmniej sześciu niewyłączonych członków, zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzygnięcie nie zapada. Posiedzeniu przewodniczy niewyłączony Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, a w braku takiej osoby — niewyłączony członek wybrany przez uczestniczących członków. Rozstrzygnięcie podpisują wszyscy uczestniczący w jego wydaniu; nie stosuje się art. 30 ust. 1 w zakresie podpisywania rozstrzygnięcia ani art. 32 ust. 4–6.

12. W razie braku kworum wskutek wakatu lub wyłączenia odwołania nie przekazuje się składowi trzyosobowemu ani innemu organowi. Stosuje się odpowiednio ust. 2d. Od rozstrzygnięcia Rady kończącego postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Koronnego Trybunału Administracyjnego na zasadach Koronnego Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Art. 46. 1. Rada prowadzi rejestr chorób publicznych i rejestr uchwał w sprawach zdrowia indywidualnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

2. Rejestr chorób publicznych obejmuje nazwę, definicję, kryteria, środki i okres obowiązywania.

3. Rejestr uchwał obejmuje dane anonimowe, przedmiot uchwały i wynik; dane osobowe są chronione.

4. Rada przekazuje ministrowi zdrowia dane statystyczne i informacje o zagrożeniach.

Art. 47. 1. Rada może wydawać zalecenia, apele i opinie w sprawach zdrowia publicznego i indywidualnego.

2. Zalecenia nie są aktami normatywnymi; nie mogą nakładać obowiązków ani ograniczać praw.

3. Zalecenia ogłasza się w Monitorze Krulewskim i na stronie internetowej Rady.

Art. 48. 1. Rada współpracuje z Senatem, Krulem, Rządem Koronnym, ministrem zdrowia, gminami, prowincjami, podmiotami leczniczymi, Koronną Służbą Ratowniczo-Gaśniczą, Policją Regionalną i Gwardią Krula.

2. Współpraca obejmuje wymianę informacji, konsultacje, wspólne ćwiczenia i działania w stanach zagrożenia.

3. Rada może powoływać ekspertów i zespoły doradcze.

Art. 49. 1. Przy Radzie działa Koronny Komitet Zdrowia Publicznego jako organ opiniodawczo-koordynacyjny.

2. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Rady, ministra zdrowia, gmin, prowincji, Koronnej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Koronnej Izby Kontroli.

3. Komitetowi przewodniczy Przewodniczący Rady.

4. Komitet koordynuje wykonywanie uchwał w sprawach zdrowia publicznego.

Art. 50. 1. Rada współpracuje z zagranicznymi radami lekarskimi i organizacjami międzynarodowymi.
2. Zawarcie umowy o współpracy wymaga zgody Krula.
3. Rada może uczestniczyć w międzynarodowych programach zdrowia publicznego.

ROZDZIAŁ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

Art. 51. 1. Lekarz i lekarz dentysta ponoszą odpowiedzialność zawodową za naruszenie ustawy, standardów Rady, etyki lekarskiej lub praw pacjenta.
2. Odpowiedzialność zawodowa jest niezależna od odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej służbowej.
3. Przewinieniem zawodowym jest w szczególności:
1) rażące niedbalstwo w leczeniu;
2) naruszenie tajemnicy lekarskiej;
3) fałszowanie dokumentacji;
4) wykonywanie zawodu bez PWZ;
5) odmowa pomocy w stanie nagłego zagrożenia;
6) dyskryminacja pacjenta;
7) eksperyment bez zgody;
8) niezgłoszenie choroby publicznej;
9) przyjęcie korzyści za skierowanie lub receptę.

Art. 52. 1. Rada powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego na 6 lat.
2. Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające, może przesłuchiwać, żądać dokumentów i zasięgać opinii biegłych.
3. Rzecznik może wystąpić do Rady o zawieszenie PWZ do czasu zakończenia postępowania, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów.
4. Obwiniony ma prawo do obrony, wglądu w akta i pełnomocnika.

Art. 53. 1. Orzekanie w sprawach zawodowych należy do Koronnego Sądu Lekarskiego, będącego organem odpowiedzialności zawodowej stanu lekarskiego, a nie sądem sprawującym wymiar sprawiedliwości w rozumieniu Konstytucji. Jego członkowie nie uzyskują statusu sędziów koronnych, a rozstrzygnięcia mają charakter rozstrzygnięć zawodowych podlegających kontroli sądowoadministracyjnej.
2. Sąd Lekarski składa się z trzech członków: dwóch lekarzy lub lekarzy dentystów powołanych przez Radę i jednego doradcy prawnego.
3. Sąd rozpatruje sprawę na rozprawie; stosuje się odpowiednio Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Orzeczenie zawiera rozstrzygnięcie, uzasadnienie i pouczenie o odwołaniu.

Art. 54. 1. Karami zawodowymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie PWZ na okres od 6 miesięcy do 5 lat;

4) pozbawienie PWZ w razie rażącego naruszenia prawa lub etyki.

2. Rada może jednocześnie nałożyć obowiązek szkolenia, przeproszenia pacjenta lub naprawienia szkody.

3. Kary podlegają zatarciu po 5 latach od uprawomocnienia, z wyjątkiem pozbawienia PWZ.

Art. 55. 1. Od orzeczenia Koronnego Sądu Lekarskiego przysługuje skarga do Koronnego Trybunału Administracyjnego w terminie 30 dni.

2. Skargę rozpatruje się na rozprawie; stosuje się przepisy o postępowaniu przed Koronnym Trybunałem Administracyjnym.

3. Skargę rozpoznaje Izba Rozpoznawcza Koronnego Trybunału Administracyjnego. Od jej orzeczenia przysługują środki zaskarżenia do Kapituły Kasacyjnej na zasadach Koronnego Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Prawomocność orzeczeń oraz nadzwyczajny arbitraż Krula określają przepisy tego kodeksu.

Art. 56. 1. Rada może zawiesić PWZ w trybie art. 23 ust. 2.

2. Zawieszenie stanowiące zabezpieczenie na czas postępowania dyscyplinarnego nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy, chyba że Koronny Trybunał Administracyjny, na uzasadniony wniosek Rady i po umożliwieniu stronie zajęcia stanowiska, przedłuży je na czas oznaczony ze względu na utrzymujące się bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów. Jest to szczególny limit wobec art. 23 ust. 3; nie dotyczy kary zawieszenia PWZ orzeczonej na podstawie art. 54.

3. Od decyzji o zawieszeniu przysługuje odwołanie do Rady w pełnym składzie na zasadach art. 45 ust. 9–12, a następnie skarga do Koronnego Trybunału Administracyjnego.

Art. 57. 1. Odpowiedzialność zawodowa nie wyłącza odpowiedzialności karnej i cywilnej.

2. Fałszowanie dokumentacji medycznej, poświadczenie nieprawdy i narażenie życia lub zdrowia podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych.

3. Rada współpracuje z organami ścigania i sądami.

ROZDZIAŁ 6
NADZÓR, KONTROLA I PRZEJRZYSTOŚĆ

Art. 58. 1. Senat Koronny sprawuje nadzór nad Radą w zakresie zgodności jej działalności z Konstytucją, ustawą i Regulaminem Rady.

2. Senat może uchylić uchwałę Rady w terminie 30 dni od jej ogłoszenia, jeżeli jest niezgodna z prawem, większością 3/5 ustawowej liczby senatorów.

3. Uchylenie uchwały wymaga uzasadnienia i jest jawne.

4. Senat rozpatruje raport Rady, o którym mowa w art. 34.

Art. 59. 1. Uchwały Rady w sprawach zdrowia publicznego, standardów i etyki oraz uchwały organizacyjne podlegają kontroli Koronnego Trybunału Administracyjnego w zakresie zgodności z prawem koronnym i prawem naturalnym.
2. Uchwały Rady w sprawach zdrowia indywidualnego podlegają zaskarżeniu do Koronnego Trybunału Administracyjnego.
3. Orzeczenia Koronnego Sądu Lekarskiego podlegają zaskarżeniu do Koronnego Trybunału Administracyjnego.
4. Decyzje Rady w sprawach PWZ podlegają zaskarżeniu do Koronnego Trybunału Administracyjnego.

Art. 60. 1. Rada podlega kontroli Koronnej Izby Kontroli w zakresie legalności, gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych.
2. Rada przedstawia Koronnej Izbie Kontroli roczne sprawozdanie finansowe.
3. Wyniki kontroli są jawne, z zachowaniem tajemnicy lekarskiej i danych osobowych.

Art. 61. 1. Rada publikuje na stronie internetowej uchwały, raporty, rejestry i informacje o działalności, z wyjątkiem danych chronionych.
2. Protokoły posiedzeń są jawne po usunięciu informacji poufnych.
3. Rada prowadzi rejestr interesów członków i oświadczenia majątkowe na zasadach ogólnych.

Art. 62. 1. Pacjent może złożyć skargę do Rady na naruszenie praw pacjenta.
2. Rada rozpatruje skargę w terminie 30 dni; w sprawach złożonych — 60 dni.
3. Skarga nie wyłącza prawa do sądu, Koronnego Trybunału Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.
4. Rada publikuje zbiorcze informacje o skargach, zanonimizowane.

ROZDZIAŁ 7
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 63. 1. Senat Koronny powoła pierwszy skład Rady w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący w terminie 30 dni od powołania.

Art. 64. 1. Osoby wykonujące zawód lekarza lub lekarza dentysty w dniu wejścia w życie ustawy uznaje się za posiadające PWZ.
2. Rada wpisze te osoby do rejestru w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
3. Dotychczasowe dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu zachowują ważność do czasu wpisu.

Art. 65. Ustawa wchodzi w życie z dniem publikacji.

Załącznik nr 1

do ustawy z dnia 25.10.2026 r. o Naczelnej Koronnej Radzie Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

ROTA ŚLUBOWANIA LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Uroczyście ślubuję służyć wiernie Koronie Krulestwa Multikont, strzec życia i zdrowia jej obywateli i mieszkańców, przestrzegać Konstytucji, ustaw i prawa naturalnego, zachować tajemnicę lekarską, nieść pomoc każdemu bez względu na pochodzenie, stan i majętność, a w sprawach zdrowia publicznego kierować się wiedzą, sumieniem i dobrem wspólnym. Tak mi dopomóż honor i sumienie.

Ślubowanie składa się przed Przewodniczącym Rady w obecności dwóch członków Rady; fakt złożenia ślubowania odnotowuje się w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów.